



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA PONEK
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
MEI 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

LAPORAN KINERJA PONEK BULAN MEI 2026

RS PRIMA HUSADA MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan ibu dan bayi baru lahir merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neonatal (AKN) masih menjadi tantangan besar, di mana banyak kematian tersebut disebabkan oleh komplikasi obstetri dan neonatal yang sebenarnya dapat dicegah melalui penanganan yang cepat dan tepat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, penyebab utama kematian ibu antara lain perdarahan, preeklampsia/eklampsia, infeksi, serta komplikasi persalinan, sementara kematian neonatal sering terjadi akibat asfiksia, infeksi, dan bayi berat lahir rendah (BBLR).

Untuk menurunkan AKI dan AKN, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengembangkan Layanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) sebagai upaya memperkuat sistem rujukan maternal dan neonatal. PONEK merupakan layanan terpadu di rumah sakit yang menyediakan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal 24 jam dengan tenaga kesehatan terlatih, fasilitas memadai, serta standar prosedur yang jelas. Implementasi layanan PONEK secara optimal diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

Rumah Sakit Prima Husada adalah sebuah Rumah Sakit Swasta tipe C yang terletak di Banjararum Selatan, Singosari, Malang. Rumah sakit berperan sebagai ujung tombak dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan juga berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas kesehatan maternal-neonatal di Indonesia dan mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat. Demi terselenggaranya keberhasilan PONEK diperlukan dukungan berbagai aspek krusial yang saling terkait, mulai dari penyediaan sumber daya manusia hingga penguatan sistem rujukan.

Pertama, rumah sakit menyiapkan tim medis khusus yang terdiri dari dokter spesialis obstetri-ginekologi, dokter anak, dokter anestesi, dan tenaga bedah, perawat dan bidan yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Kompetensi tim ini terus dijaga melalui program pelatihan berkala dan simulasi kasus gawat darurat. Infrastruktur menjadi pilar penting lainnya. Rumah sakit menyediakan ruang PONEK yang beroperasi 24 jam, dilengkapi dengan ruang bersalin, ruang operasi cesar, serta ruang perawatan intensif untuk ibu (PICU) dan bayi baru lahir (NICU). Kelengkapan alat medis, Laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan cepat dan bank darah yang siap pakai turut mendukung kesiapan penanganan kasus emergensi. Sistem rujukan yang efektif dibangun melalui kerja sama erat dengan fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas

dan klinik.

Protokol klinis yang jelas menjadi panduan tim medis dalam menangani berbagai komplikasi. Rumah sakit menyusun standar operasional prosedur untuk menangani perdarahan, eklampsia, sepsis, dan distosia persalinan, termasuk alur cepat untuk pasien kritis. Audit maternal-perinatal secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kualitas layanan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dukungan administratif dan pendanaan menjadi tulang punggung operasional PONEK. Rumah sakit mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan SDM, pemeliharaan alat, dan penyediaan obat-obatan emergensi.

Laporan bulanan ponek dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran pelayanan PONEK yang ada di RS Prima Husada Malang.

1.2 Dasar Hukum

- .1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938/Menkes/SK/VII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan serta mengutamakan keselamatan pasien.

1.3.2 Tujuan

1. Memberikan informasi pelayanan PONEK
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan PONEK
3. Menetapkan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit Berkualitas Prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan pasien dan keselamatan pasien
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

2.3 Motto

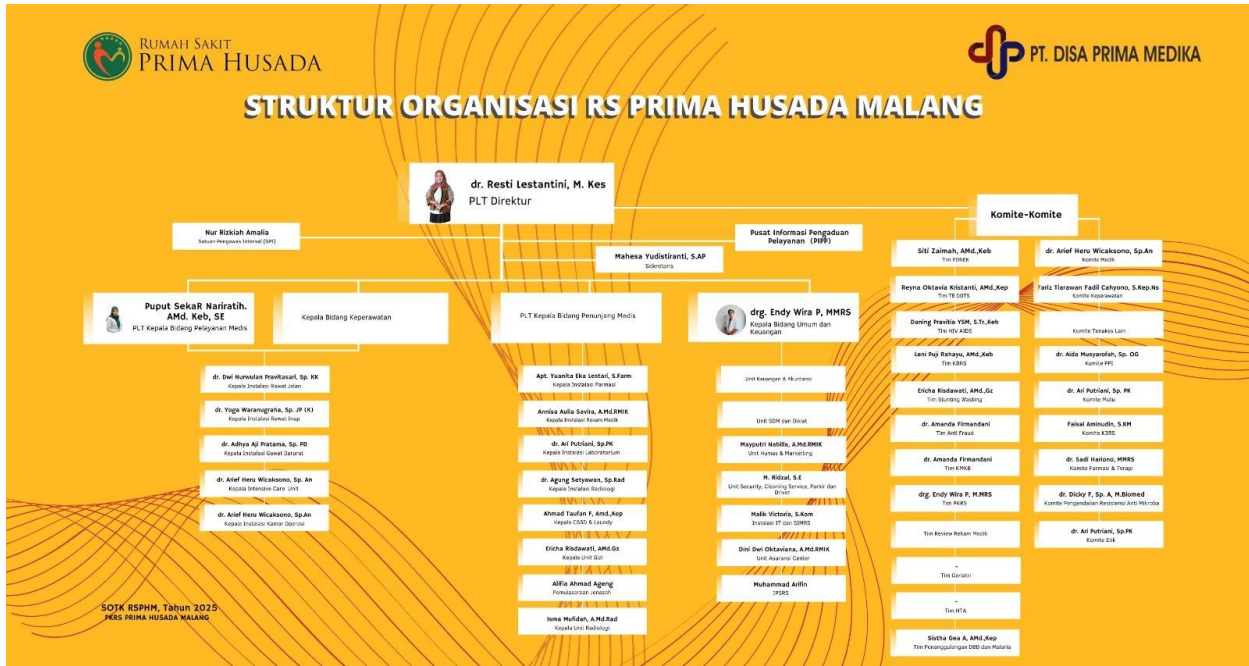
Sahabat menuju sehat

2.4 7 Nilai Budi Utama

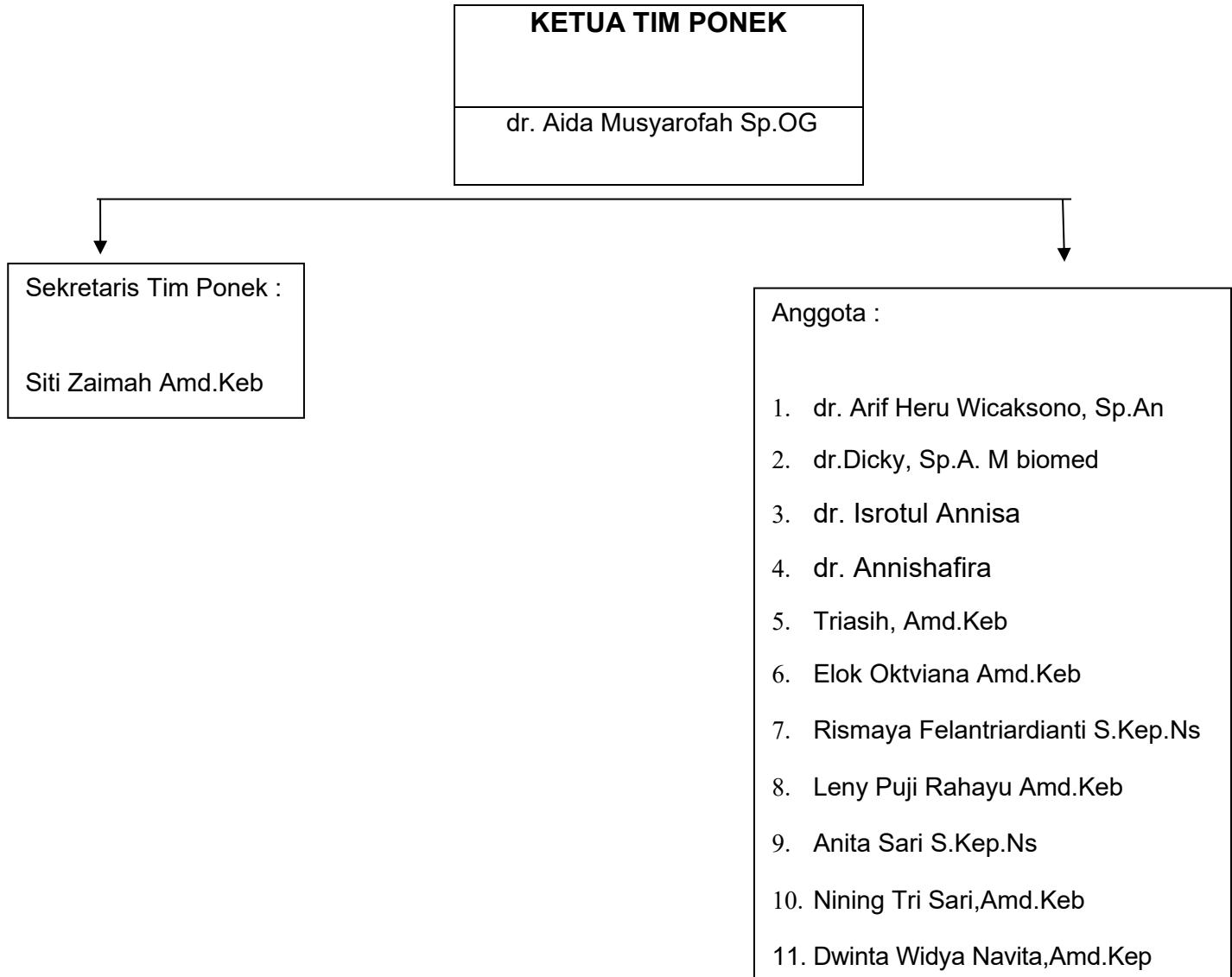
Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adii
7. Peduli

2.5 SOTK



STRUKTUR ORGANISASI TIM PONEK
RS PRIMA HUSADA MALANG



Analiasa	- Jumlah Tim PONEK secara keseluruhan adalah berjumlah 11 orang. Masing - masing anggota memegang jabatan yang berbeda. - Program rotasi: Program rotasi tim PONEK berlaku bila kinerja anggota tidak memenuhi standart tim PONEK dan bila ada anggota yang resign. Pada bulan Mei 2026 tidak ada pergantian anggota Tim PONEK
Rencana Tindak lanjut	Koordinasi dengan Tim PONEK untuk mengembangkan pelayanan. Serta melakukan pelatihan inhouse training dan Drill Emergency terkait kegawat daruratan maternal Neonatal.

BAB III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 Pola Ketenagaan

3.1.1 Jumlah SDM

Tabel 3.1.1 Jumlah SDM Tim Ponek RSPHM bulan Mei 2026

Jabatan	Jumlah SDM				Ket.
	Standar	Maret 2026	April 2026	Mei 2026	
Ketua Tim Ponek	1	1	1	1	
Sekretaris Tim Ponek	1	1	1	1	
Anggota Tim Ponek	11	11	11	11	

3.1.2 Pemenuhan kualifikasi SDM

Tabel 3.1.2 Kualifikasi SDM RSPHM Tim Ponek RSPH Mei 2026

Jabatan	Pendidikan	Sertifikasi		Keterangan
	Standar	Ponek (Wajib)	PPGDON (Wajib)	
Ketua Tim Ponek : dr. Aida Musyarofah Sp.OG	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
Sekretaris Tim Ponek : Siti Zaimah Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
1. dr. Arif Heru Wicaksono, Sp.An	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
2. dr. Dicky, Sp.A M biomed	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
3. dr. Isrotul Annisa	Dokter	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Dokter IGD
4. dr. Annishafira	Dokter	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Dokter IGD
5. Triasih, Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
6. Elok Oktviana Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
7. Rismaya Felantriardianti S.Kep.Ns	Perawat	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Perawat Neonatologi
8. Leny Puji Rahayu Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Bidan Poli
9. Dwinta Widya Navita,Amd.Kep	Perawat	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Perawat ICU

3.1.4 Hasil Pelaksanaan Peningkatan SDM Tim Ponek di RSPH Malang Bulan Mei 2026

Tabel 1.4 Hasil Pelaksanaan Peningkatan SDM Tim Ponek di RSPH Malang Bulan Mei 2026

NO	Tema DIKLAT /WS/SEM/WB	Jenis Diklat	JUMLAH PESERTA		TGL Pelak sanaan	Hasil evaluasi dalam kinerja sehari-hari
			Hadir	Tidak Hadir		
	-					

3.2. Fasilitas PONEK

Tabel 3.2. Fasilitas Ponek RSPHM bulan Mei 2026

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	USG Transport	Ruang tindakan	1 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
2	USG 4D	Poli kandungan	1	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 4/09/2025
3	IUD SET	Poli kandungan Ruang tindakan	2 set 2 set	Baik Siap Pakai	
4	Inkubator	Perinatologi	5 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
5	Cuvis	Perinatologi	4 unit	Baik Siap Pakai	
6	Monitor ECG	Ruang tindakan	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 2/9/2025
7	Box bayi	Perinatologi	15 unit	Baik Siap Pakai	
8	Fototerapi	Perinatologi	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
9	Suction bayi	Ruang tindakan/ IKO	1 set 1 set	Baik Siap Pakai	
10	Partus Set	Ruang tindakan	7 set	Baik Siap Pakai	
11	Curetage set	Ruang tindakan	4 set	Baik Siap Pakai	
12	Vacum manual	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
13	Timbangan bayi	Ruang tindakan, NICU, PONEK	3 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
14	NST/CTG	Ruang tindakan, PONEK	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/9/2025
15	Dopler	Ruang tindakan IGD Ponek	2 unit 1 Unit	2 unit baik 1 Unit	Kalibrasi 8/09/2025
16	Infarm warmer	Ruang tindakan. IKO IGD ponek	3 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 3/9/2025
17	Forsep	IKO	1 set	Baik Siap Pakai	
18	C-PAP Mesin	Perinatologi	5 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
19	Vakum set manual	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
20	AmbuBag Bayi	Ruang tindakan	3 set	Baik Siap Pakai	
21	Ambubag Dewasa	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
22	Larigoskop bayi dan anak	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
23	Oxymetri neonates	Ruang perinatologi	1 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
24	Pulse oksimetri neonates baru	Ruang Perinatologi	4 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
25	Sendok kuret makro no 8 dan 10	Ruang Tindakan	2 unit	Baik siap pakai	
26	Micro curret	Ruang Tindakan	1 unit	Baik siap pakai	
27	Sendok Curret	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
28	HPP set	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
29	Busi kecil	Ruang Tindakan	2 set	Baik siap pakai	
30	Busi besar	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
31	Spekulum besar	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
32	Spekulum sedang	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	
33	Spekulum kecil	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	
34	Nalfuder No 20	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik Siap pakai	
35	Inkubator transport	Ruang Perinatologi	1 Unit	Baik Siap pakai	Kalibrasi 8/09/2025

Analisis :

- 1) Secara umum kondisi fasilitas dan peralatan PONEK cukup lengkap, Khusus alat penunjang medis yang elektrik sudah terkalibrasi
- 2) Bulan Mei tidak ada penambahan alat
- 3) Jadwal kalibrasi rencana bulan September 2026

Rencana Tindak lanjut :

- 1) Melakukan pengecekan alat setiap 1 bulan sekali oleh PJ alat di supervise oleh karu
- 2) Melakukan pemeliharaan alat secara berkala setiap 1 bulan sekali oleh IPSRS
- 3) Melakukan kalibrasi setiap 1 tahun sekali yang rencana akan dilakukan pada bulan September 2026

3.3 Kinerja Produktivitas

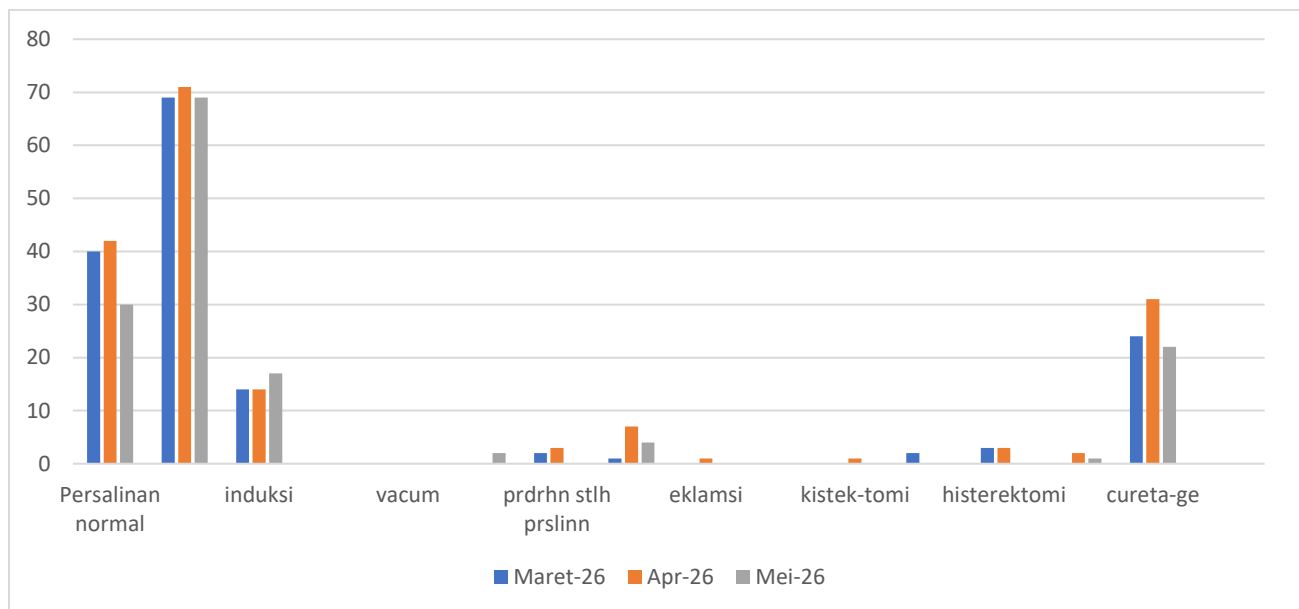
3.3.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal

Tabel 3.3.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek RSPHM Mei 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Maret 2026	Bulan April 2026	Bulan Mei 2026
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	40	42	30
	b. <i>SectioCaesaria</i>	69	71	69
2				
	a. Induksi / Drip	14	14	17
	b. Sungsang	0	0	0
	c. Vacuum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	2
	b. Perdarahan setelah Persalinan	2	3	0
	c. Pre Eklamsi	1	7	4

4	d. Eklamsi	0	1	0
	e. Infeksi	0	0	0
	a. Curretage	24	31	22
	b. Kistektomi	0	1	0
	c. Miomektomi	2	0	0
	d. Histerectomy	3	3	0
	e. KET	0	2	1

Grafik 3.3.1
Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis:

- 1) Pada jenis persalinan normal pada bulan Mei 2026 yaitu 30 pasien menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 42 pasien, sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 40 pasien.
- 2) Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Mei 2026 yaitu 69 pasien menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 71 pasien, sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 69 pasien,.
- 3) Pasien terbanyak yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas SC, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, CPD atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal

distres. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi SC cito.

- 4) Tidak ada persalinan sungsang pada bulan Mei 2026 dan 2 bulan sebelumnya. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Mei 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
- 5) Induksi/ Drip pada bulan Mei sebanyak 17 pasien, meningkat dibandingkan bulan April dan Maret 2026 yaitu 14 pasien. Ini disebabkan kontraksi pasien inpartu sudah adekuat sehingga tidak perlu diberikan tambahan induksi/drip.
- 6) Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Mei 2026 yaitu 4, menurun dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 7, sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 1 kasus.
- 7) Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah eklamsi. Pada bulan Mei 2026 yaitu 0 kasus, menurun dibandingkan dengan bulan April 1 kasus, sedangkan Maret 2026 yaitu 0 kasus.
- 8) Jenis pelayanan curretage di bulan Mei 2026 yaitu 22 kasus, menurun jika dibandingkan dengan April 2026 yaitu 31 pasien, sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 24 pasien. *Curetage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.
- 5) Melakukan edukasi kepada pasien ANC untuk melakukan senam hamil

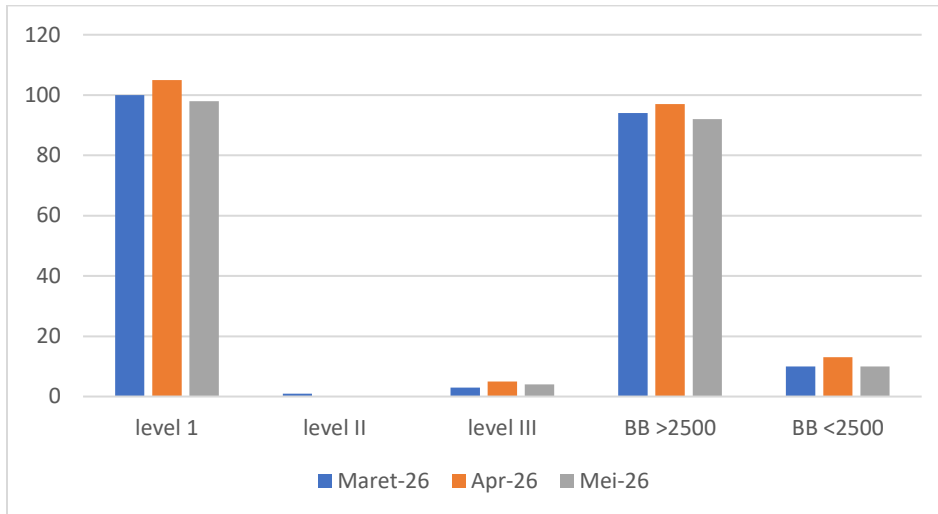
3.3.2. Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

Tabel 3.3.2 tabel jumlah kegiatan pelayanan neonatal Ponpek RSPHM Mei 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Maret 2026	Bulan April 2026	Bulan Mei 2026
1				
	a. Level 1/ rawat gabung	100	105	98
	b. Level II/ rujukan dari luar	1	0	0
	c. Level III/NICU	3	5	4
2				
	a. BB $\geq$ 2500 gram	94	97	92

b. BB ≤ 2500 gram	10	13	10
-------------------	----	----	----

Grafik 3.3.2
Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis :

- 1) Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1/ rawat gabung di bulan Mei 2026 yaitu 98 pasien menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 105 pasien , sedangkan Maret 2026 yaitu 100 pasien
- 2) Pada pelayanan level 2/ rujukan dari luar pada bulan Mei dan April 2026 yaitu 0 pasien , menurun dibandingkan pada bulan Maret 2026 yaitu 1 pasien.
- 3) Pada pelayanan level 3 pada bulan Mei yaitu 4 pasien, menurun jika dibandingkan dengan April yaitu 5 pasien, sedangkan bulan Maret yaitu 3 pasien.
- 4) Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah BB >2500 gram di bulan Mei 2026 yaitu 92 pasien menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 97 pasien, sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 94 pasien.
- 5) Jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Mei 2026 yaitu 10 pasien, menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 13 pasien, dan Maret 2026 yaitu 10 pasien. Ini disebabkan karena masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

-
- 3) Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.3.3 Jumlah Kelahiran Mati Neonatal

Tabel 3.3.3 Jumlah Kelahiran Mati Neonatal RSPHM Bulan Mei 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Maret 2026	April 2026	Mei 2026
1	Kelahiran Mati /IUFD	1	2	2
2	Mati Neonatal < 7 Hari yang partus di PHM	1	1	0
3	Mati Neonatal < 7 Hari yang rujukan dari luar	0	1	0

Analisis:

- 1) Bulan Mei dan April 2026 ada 2 kasus kelahiran mati/IUFD, sedangkan bulan Maret 2026 ada 1 kasus.
- 2) Bulan Mei tidak ada kasus kematian neonatus <7 hari yang lahir di RS, sedangkan bulan April dan Maret ada 1 kasus.
- 3) Bulan Mei tidak ada kasus kematian neonatus <7 hari yang bayi rujukan, sedangkan bulan April ada 1 kasus. Dan Maret tidak ada.

Rencana dan Tindak Lanjut

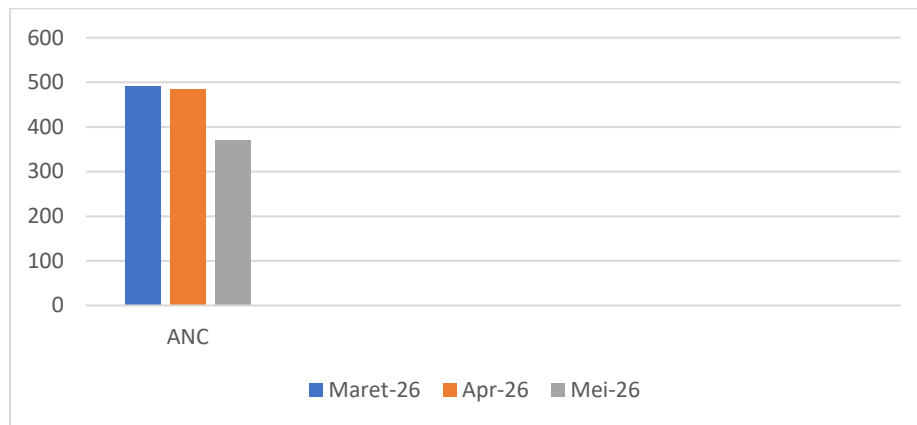
- 1) Melakukan Notifikasi di aplikasi MPDN segera 1 x 24 jam untuk semua kematian.
- 2) Melengkapi RMP (Rekam Medis Perinatal) di aplikasi MPDN kurang dari 7 hari untuk bayi IUFD UK > 28 minggu, dan kelahiran bayi mati sampai usia 28 hari
- 3) Melakukan audit maternal neonatal internal RS

3.3.4 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

Tabel 3.3.4 Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek RSPHM Mei 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Maret 2026	Bulan April 2026	Bulan Mei 2026
1	ANC	491	485	371

Grafik 3.3.4
Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis

- 1) Berdasarkan data kunjungan Ante Natal Care (ANC), Pada bulan Mei, jumlah kunjungan mengalami penurunan yang lebih signifikan menjadi 371 kunjungan. Jika dibandingkan dengan bulan April, terjadi penurunan sebanyak 114 kunjungan atau sekitar 23,5%. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan berkurangnya pemanfaatan layanan ANC oleh ibu hamil. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi kondisi tersebut antara lain Faktor yang mungkin memengaruhi penurunan ini antara lain jadwal kontrol pasien yang bergeser ke bulan berikutnya, variasi jumlah pasien baru, atau faktor eksternal seperti hari libur dan kondisi akses pelayanan atau faktor sistem dan Kebijakan terkait perubahan regulasi JKN
- 2) Secara keseluruhan, tren kunjungan ANC pada periode Maret-Mei 2026 menunjukkan kecenderungan menurun, terutama pada bulan Mei. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebab penurunan kunjungan serta penguatan upaya promosi kesehatan, pemantauan ibu hamil berisiko, dan peningkatan edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin agar cakupan pelayanan ANC tetap optimal

3) Rencana dan Tindak Lanjut

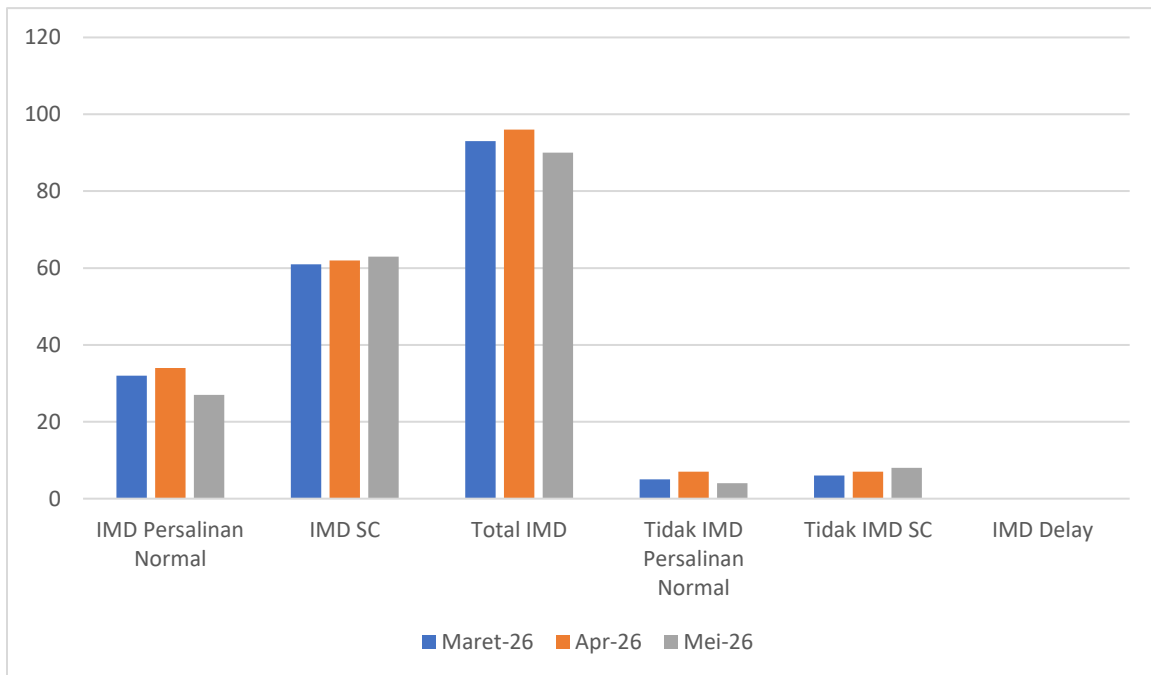
- 1) Melakukan promosi kesehatan terkait pemeriksaan ANC di dokter spesialis Obgyn
- 2) Melakukan Promosi layanan ANC risiko tinggi
- 3) Melakukan Program kelas ibu hamil

3.3.5 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tabel 3.3.5 Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) IMD Mei 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien					
		Bulan Maret 2026	%	Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%
1	IMD Persalinan Normal	32	86,5%	34	82,9%	27	87%
2	IMD SC	61	91,0%	62	89,9%	63	88,7%
3	Total IMD	93	89,4%	96	87,3%	90	88,2%
4	Tidak IMD Persalinan Normal	5	13,5%	7	17,1%	4	12,9%
5	Tidak IMD SC	6	9,0%	7	10,1%	8	11,2%
6	IMD Delay	0	0%	0	0%	0	0%
	Total Kelahiran Normal	37		41		31	
	Total Kelahiran SC	67		69		71	
	Total kelahiran	104		110		102	

Grafik 3.3.5
Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis :

- 1) Pada bulan Mei 2026 jumlah IMD persalinan normal yaitu 27 (87%) pasien, menurun di bandingkan bulan April yaitu 34 (82,9%) pasien sedangkan bulan Maret yaitu 32 (86,5%) pasien Bayi.
- 2) Sedangkan IMD pada kelahiran SC pada bulan Mei yaitu 63 (88,7%) pasien, meningkat sedikit dibanding dengan bulan April 62 (89,9%) pasien, dan bulan Maret yaitu 61 (91%) pasien.
- 3) Kejadian tidak dilakukan IMD pada persalinan normal bulan Mei yaitu 4 (12,9%) pasien, menurun dibandingkan bulan April yaitu 7 (17,1%) sedangkan bulan Maret yaitu 5 pasien (13,5%)
- 4) Kejadian tidak dilakukan IMD pada kelahiran SC bulan Mei 2026 yaitu 8 (11,2%) pasien, meningkat dibandingkan bulan April 2026 yaitu 7 (10,1%), sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 6 (9,0%) pasien
- 5) Bayi yang tidak dilakuan IMD dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD dikarenakan membutuhkan penanganan lebih lanjut seperti bayi BBL dengan perawatan infant warmer, bayi dengan pemakaian CPEP.
- 6) Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Mei 2026

No	Nama Bayi	Diagnosa	Perawatan BBL
Persalinan Normal			
1	By Ny Firnanda	NKB + BBLR	Cuvis

2	By Ny miftakhul	NCB + BBLR	Infarn Warmer
3	By Ny Yulis	NKB + BBLR	Infarn Warmer
4	Ny Ny Fitri Nadhila	Pneumonia	CPEP + inkubator
SC			
1	By Ny Nuhda Akmalia	NKB + BBLR	Cuvis
2	By Ny Miratus Suaibah	NKB + BBLR	CPEP + inkubator
3	By Ny Elma kania	NCB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Ziadatul Azizah	NKB + BBLR	Cuvis
5	By Ny Siti Kholifah	NKB + BBLR	Cuvis
6	By Ny Mei Ria	NCB + BBLR	Cuvis
7	By Ny Alfiah	NKB + BBLR	Cuvis
8	By Ny Hindun	Obs distres nafas ok Neonatal Pneumonia dd MAS, susp congenital anomaly dd achondroplasia	CPEP + inkubator

Rencana dan Tindak Lanjut

1. Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak
2. Mempertahankan Konsistensi Pelaksanaan IMD
3. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan IMD
4. Edukasi sejak ANC tentang manfaat IMD dan ASI eksklusif.

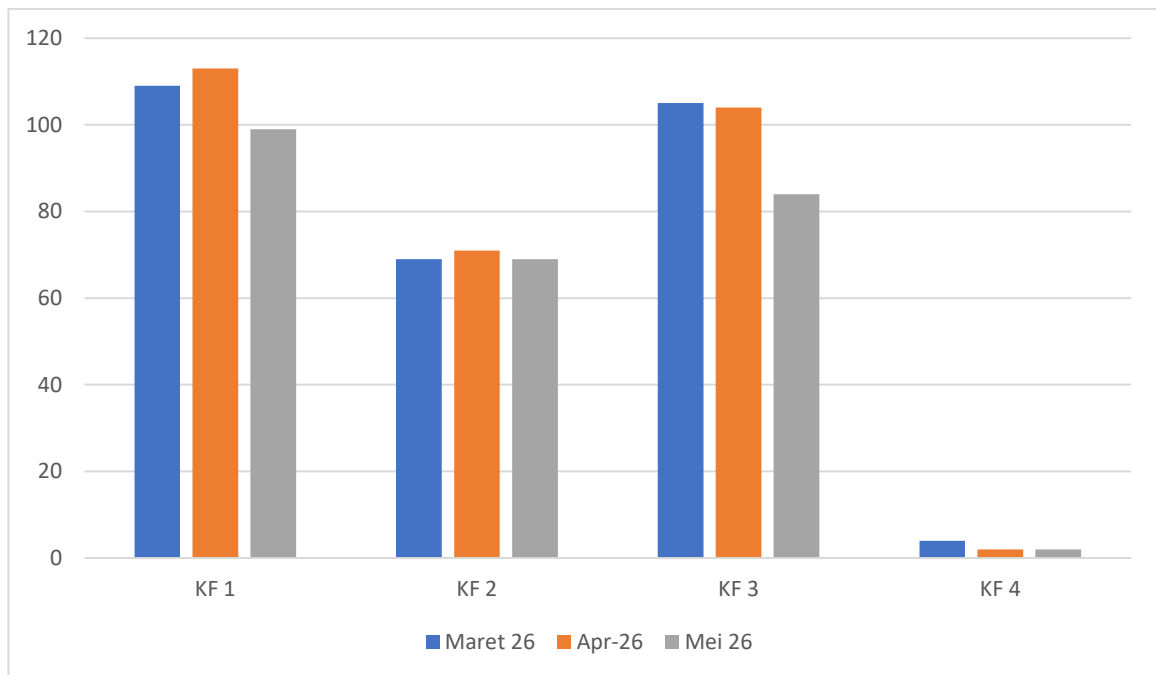
3.3.6 Pelayanan Post Natal Care (PNC)

Tabel 3.3.6 Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek RSPHM Mei 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah					
		Bulan Maret 2026	%	Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%
1	KF 1 (6-4 jam)	109	100%	113	100%	99	100%
2	KF2: 3–7 hari	69	63,3%	71	62,%	69	69,6%
3	KF 3 (8- 28 hari)	105	96,2%	104	92%	84	84,8 %
4	KF4: 29–42 hari)	4	3,67%	2	2,1%	2	2%
	∑ kelahiran Normal	40		42		30	
	∑ kelahiran SC	69		71		69	
	Total kelahiran	109		113		99	

Grafik 3.3.6

Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis:

1. Dari tabel dan grafik 3.3.6 Kunjungan PNC KF 1 pada bulan Mei yaitu 99 pasien (100%), pada bulan April yaitu 113 pasien (100%), sedangkan pada bulan Maret 109 pasien (100%), ini artinya semua pasien post partum melakukan kunjungan pada KF1
2. Pada kunjungan KF 2 pada bulan Mei yaitu 69 pasien (69,6%), pada bulan April yaitu 67 pasien (71,2%), sedangkan pada bulan Maret 69 pasien (63,3%), capaian KF 2 belum 100% di karenakan pasien post partum normal hari ke 2 sudah diijinkan pulang dan jadwal kontrol ulang hari ke 8 pasca rawat inap.
3. Pada kunjungan KF 3 pada bulan Mei yaitu 84 pasien (84,8%) pada bulan April yaitu 104 pasien (92%) sedangkan pada bulan Maret yaitu 105 pasien (96,2%), capaian KF 3 belum 100% di karenakan masuk laporan bulan sebelumnya atau bulan setelahnya.
4. Pada kunjungan KF 4 pada bulan Mei dan April yaitu 2 pasien (2,1%), sedangkan pada bulan Maret 4 pasien (3,67%), pada KF 4 cakupan hanya sedikit di karenakan pasien post partum dan post SC setelah kunjungan KF 3 pasien tidak ada komplikasi untuk pemantauan di kembalikan ke faskes 1, pasien KF 4 yang masih bias di layani di faskes 2 dikarenakan ada masalah seperti infeksi luka operasi atau infeksi jahitan perineum, Tekanan Darah pasien tinggi, evaluasi sisa selaput ketuban.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan Edukasi pasien dan keluarga Jadwal kontrol nifas sesuai jadwal
- 2) Melakukan edukasi tanda bahaya nifas
- 3) Melakukan edukasi pentingnya KB pasca salin
- 4) Melakukan edukasi pemantauan nifas KF 4 di faskes 1

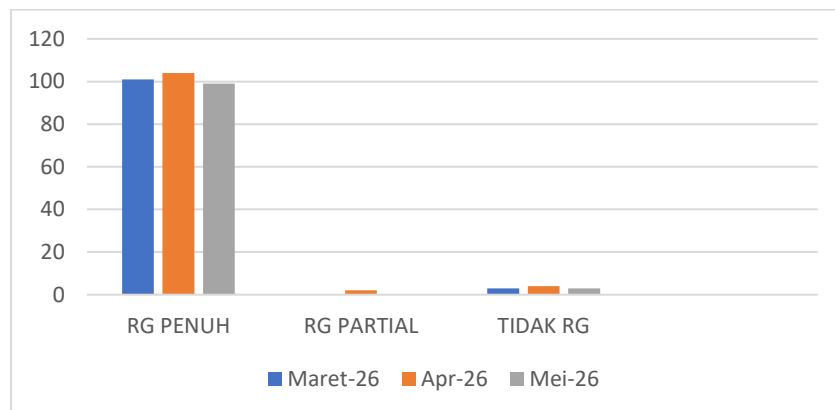
3.3.7 Pelayanan Rawat Gabung

Tabel 3.3.7 Pelayanan Rawat Gabung Ponek RSPHM Mei 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien					
		Bulan Maret 2026	%	Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%
1	Rawat gabung penuh	101	97,2%	104	94,5 %	99	97%
2	Rawat gabung partial	0	0%	2	1,8%	0	0%
3	Tidak Rawat gabung	3	2,9%	4	3,6 %	3	2,9%
Σ Kelahiran		104	-	110	-	102	-

Grafik 3.3.7

Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis :

- 1) Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Mei 2026 yaitu 99 (97%) bayi menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 104 (94,5%) bayi, sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 101 (97,2%) bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2) Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Mei 2026 yaitu 3 (2,9%) bayi, menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 4 (3,6%) bayi, dan Maret 2026 yaitu 3 (2,9%) bayi.
- 3) Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

No	Nama	Diagnosa	Perawatan BBL
1	By Ny Miratus	NKB + BBLR +RDS	CPEP + Inkubator

2	Ny Ny Fitri Nadhila	Pneumonia	CPEP + inkubator
3	By Ny Hindun	Obs distress nafas ok Neonatal Pneumonia dd MAS, susp congenital anomaly dd achondroplasia	CPEP + inkubator

- 4) Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

Rencana dan Tindak Lanjut

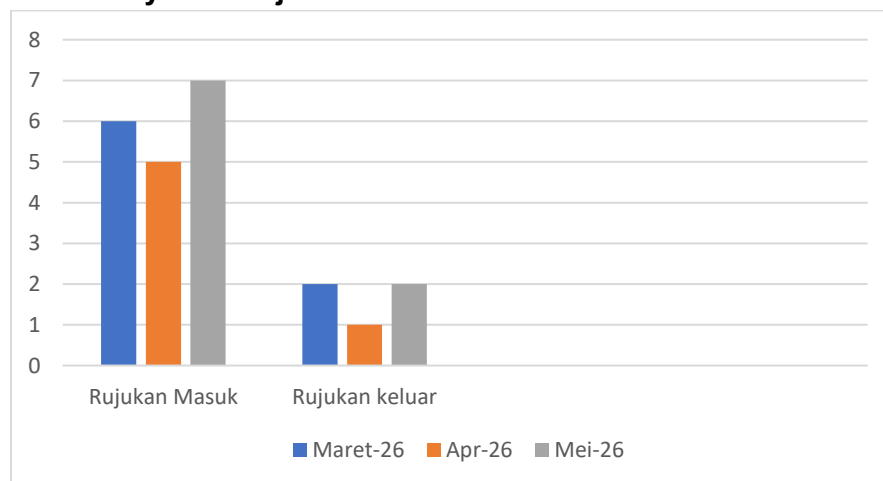
- 1) Setelah kondisi bayi stabil segera dilakukan rawat gabung atau kontak ibu-bayi.
- 2) Fasilitasi ibu untuk memerah ASI sedini mungkin (1–2 jam setelah persalinan)
- 3) Kunjungan ibu ke ruang perinatologi / NICU (jika memungkinkan)
- 4) Pelaksanaan Kangaroo Mother Care pada bayi BBLR yang sudah stabil.

3.3.8 Pelayanan Rujukan

Tabel 3.3.8 Pelayanan Rujukan Ponek RSPHM Mei 2026

No	Rujukan	Bulan Maret 2026	Bulan April 2026	Bulan Mei 2026
1	Rujukan Masuk	6	5	7
2	Rujukan keluar	2	1	2

Grafik 3.3.8
Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Mei 2026



Evaluasi :

- 1) Jumlah rujukan masuk pada bulan Mei 2026 menurun yaitu 7 rujukan, sedangkan pada bulan April 2026 menurun yaitu 5 rujukan, dan bulan Maret 2026 sebanyak 6 rujukan.
- 2) Jumlah rujukan keluar pada bulan Mei 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 2 rujukan, sedangkan pada bulan April 2026 sebanyak 1 rujukan, dan Maret 2026 sebanyak 2 rujukan.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM, Puskesmas, Klinik dan RS setempat untuk bekerja sama.
- 2) Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.3.8.1 Rujukan Masuk

Tabel 3.3.8.1 Rujukan Masuk Ponek RSPHM Mei 2026

Bulan Maret 2026			
1	Ny Wiwik Puji A	G5 P2002 Ab200 UK 39-40 minggu dengan KPD + letak Obliq	PMB Munawaroh
2	Ny Heny S	Anemia + AUB	Dr.Rifatul
3	Ny Rika S	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
4	Ny Irma S	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 minggu dengan KPD + susp CPD	PMB Titik S
5	Ny Lelly Priga	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KPD	PMB Titik S
6	Ny Cello velinda	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KPD + HT gestasional+ letak Obliq	PMB Lilik A
Bulan April 2026			
1	Ny Chusna W	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KIFA	PKM Singosari
2	NY Dwi Oktavianti	G4 P0000 Ab300 UK 38-39 minggu dengan KET	RSUD Lawang
3	Ny Siti fatonah	G2 P1001 Ab000 UK 37-38 minggu dengan Kala 2 + letsu	PMB Lilik
4	Ny Darwati	Syok hipovolemik ec AUB ec Mioma uteri	PKM Lawang
5	Ny Nina	G1 P0000 Ab000 UK 41-42 minggu dengan Kala 2	PKM Jabung
Bulan Mei 2026			
1	Ny Muspita Sari	G4 P2002 Ab100 UK 18-20 minggu dengan IUFD	KRI Putra Husada
2	Ny Sari Kurnia	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
3	Ny Vio Eka	G1 P0000 Ab000 UK 40 minggu dengan impending ekamsia	Klinik Mutiara Sehat

4	Ny Siti Muyassyaroh	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 minggu dengan KPD	PMB Munawaroh
5	Ny Alfiah	G1 P0000 Ab000 UK 36-37 minggu dengan letsu + partus prematurus + KIFA + IUGR + PER	PMB Titik S
6	Ny Sofi Andini	G3 P1001 Ab100 UK 38-39 minggu dengan KPD + KIFA	PMB Lilik Agustina
7	Ny Anita	G5 P4004 Ab000 UK 10-12 minggu dengan abortus inkomplit	PMB Titik Idmawanti

3.3.8.2 Rujukan Keluar

Tabel 3.3.8.2 Rujukan Keluar Ponak RSPHM Mei 2026

No	Nama	Usia	Unit	Diagnosa	Alasan Rujukan	Tujuan Rujukan
Bulan Maret 2026						
1	By Ny Savira	1 hari	NICU	RDS ok Neonatal pneumonia dd MAS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Soepraoen
2	NY Aisyah Kayla	30 th	Ponek	G1 P0000 Ab000 Uk 32-34 minggu dengan PEB	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
Bulan April 2026						
1	By Ny sufiati	1 hari	NICU	RDS ok HMD DD neonatal Pneumonia, BBLASR	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar
Bulan Mei 2026						
1	By Ny Miratus	0 hari	NICU	NKB + BBLR + RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi + pro surfaktan	RS Saiful Anwar
2	By Ny Hindun	4 hari	NICU	Obs distres nafas ok Neonatal Pneumonia dd MAS, susp congenital anomaly dd achondroplasia	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar

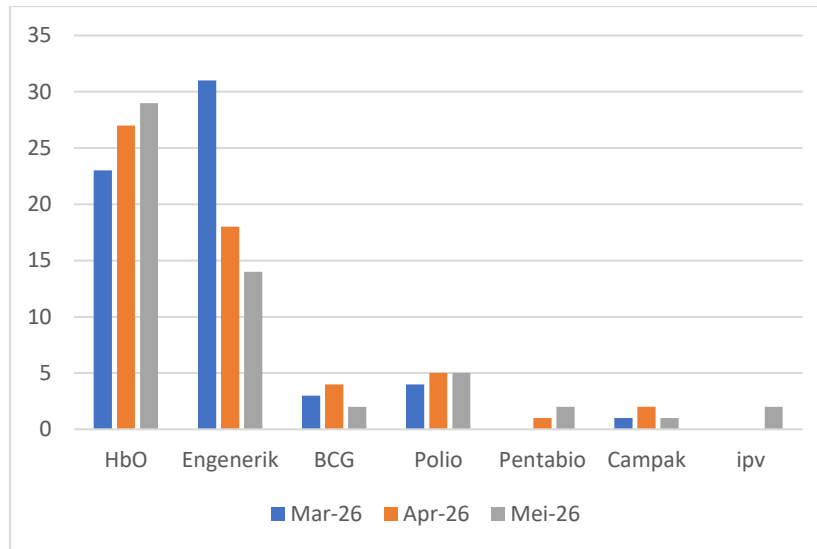
3.4 Pelayanan Imunisasi

Tabel 3.4.1 Pelayanan Imunisasi Ponak RSPHM Mei 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah					
		Bulan Maret 2026	%	Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%
1	HbO	23	21,1%	27	23,9%	29	28,4%

2	Engerix Junior	31	21,1%)	18	15,9%	14	13,7%
3	BCG	3	-	4	-	2	-
3	Polio	4	-	5	-	5	-
4	Pentabio	0	-	1	-	2	-
5	Campak	1	-	2	-	1	-
6	IPV	0	-	0	-	2	-
	Σ Kelahiran	109		113		102	

Grafik 3.4.1
Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis

- 1) Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Mei 2026 yaitu 29 (28,4%) pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 27 (23,9%) pasien, sedangkan pada bulan Maret 2026 yaitu 23 (21,1%) pasien, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HBO diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari atau pembelian vaksin Engerix Junior dengan edukasi Biaya Umum
- 2) Pada bulan Mei ada 14 (13,7%) bayi yang menggunakan vaksin Engerix Junior, menurun dibandingkan pada bulan April ada 18 (15,9%) bayi, sedangkan bulan Maret ada 31 (28%) bayi, Penggunaan vaksin Engerix Junior ini dikarenakan banyak nya bayi baru lahir yang tidak mendapatkan vaksin Hbo disebabkan persediaan Hbo yang sedikit, sehingga ditawarkan untuk pembelian Vaksin Engerix Junior.
- 3) Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Mei sebanyak 2, sedangkan bulan April 2026 dan Maret tidak ada.
- 4) Ada 2 bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Mei 2026, dan menurun dibandingkan dengan April yaitu 4 bayi, sedangkan bulan Maret 3 bayi.
- 5) Ada 1 bayi yang Imunisasi Campak bulan Mei 2026, sedangkan bulan April ada 2 bayi, dan di bulan Maret ada 1 bayi.
- 6) Ada 5 bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Mei dan April 2026, sedangkan bulan Maret ada 4 bayi.
- 7) Ada 2 bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan Mei 2026, sedangkan pada bulan April ada 1 bayi, dan pada bulan Maret tidak ada. Imunisasi pentabio

diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2) Melakukan edukasi pemberian imunisasi Engerix Junior untuk bayi baru lahir
- 3) Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

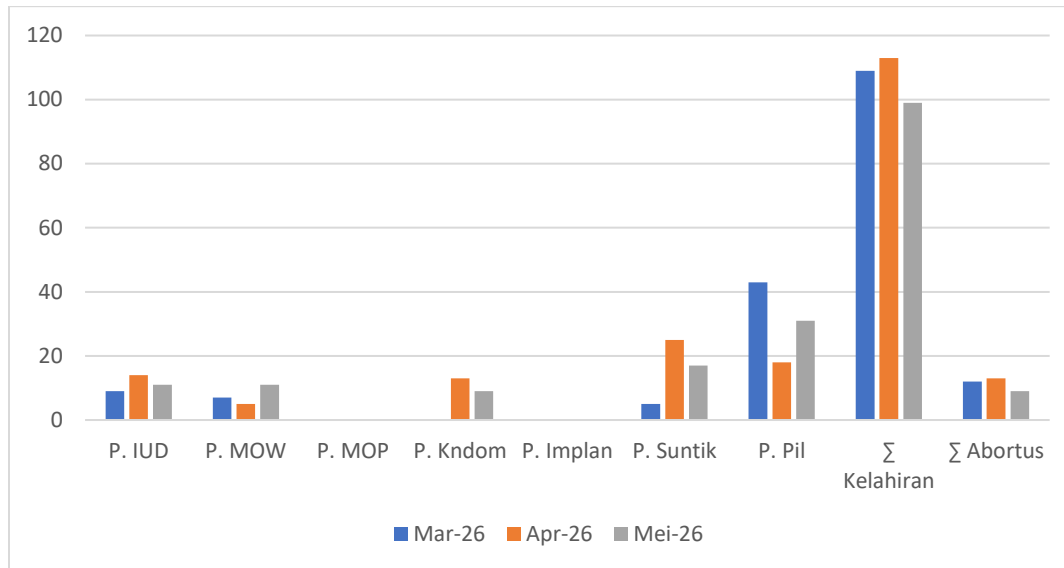
3.5 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

3.5.1 Pelayanan Pemasangan Keluarga berencana (KB) Ponpek RSPHM Mei 2026

Tabel 3.5.1 Pelayanan Pemasangan Keluarga berencana (KB) Ponpek RSPHM Mei 2026

No	Jenis	Jumlah Pasang					
		Bulan Maret 2026	%	Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%
1	IUD	9	20,9%	14	12,4%	11	11,1%
2	MOW	7	17,3%	5	4,4%	11	11,1%
3	MOP	0	-	0	-	0	-
4	Kondom	15	100%	13	100%	9	100%
5	Implant	0	-	0	-	0	-
6	Suntikan	5	-	25	-	17	-
7	Pil	43		18		31	
8	Σ Kelahiran	109		113		99	
9	Σ Abortus	15		13		9	

Grafik 3.5.1
Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis :

- 1) Pemasangan KB IUD pada bulan Mei 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 (11,1%) akseptor, pada bulan April 14 (12,4%) sedangkan pada bulan maret 9 (20,9%) Pemakaian IUD pasca salin dengan cakupan sedikit dikarenakan ada biaya jasa dokter 400.000 untuk IUD coper T, dan biaya IUD nova T 850.000.
- 2) Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Mei 2026 sebanyak 11 (11,1%) pasien, sedangkan pada bulan April 2026 sebanyak 5 (4,4%), dan bulan Maret sebanyak 7 (16,3%) pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3) Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Mei 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 9 pasien, sedangkan pada bulan April 2025 sebanyak 13 pasien, dan pada bulan Maret sebanyak 15 pasien.
- 4) Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Mei 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 31 pengguna, sedangkan pada bulan April 2026 sebanyak 18 pengguna, dan bulan Maret sebanyak 43 pengguna.
- 5) Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Mei menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 17 pengguna, sedangkan bulan April 2026 sebanyak 25 pengguna, dan bulan Maret 2026 sebanyak 5 pengguna.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.5. Pelayanan Pelepasan Keluarga Berencana (KB)

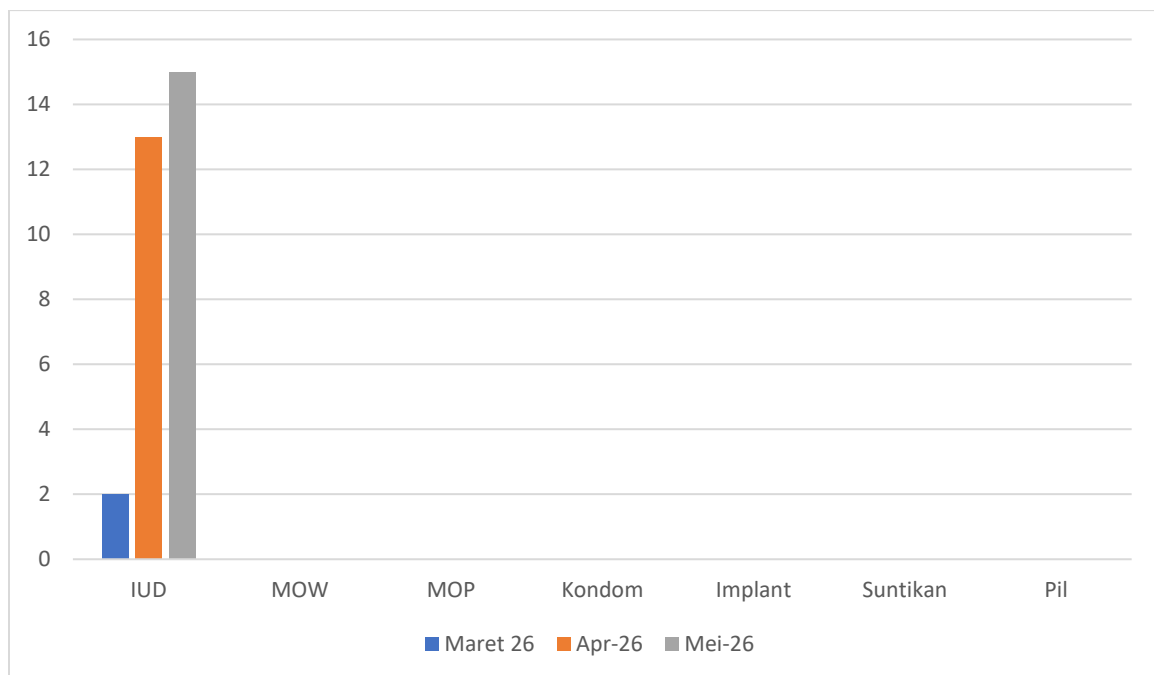
3.5.2 Pelayanan Pelepasan Keluarga berencana (KB) Ponek RSPHM Mei 2026

Tabel 3.5.2 Pelayan Pelepasan Keluarga berencana (KB) Ponek RSPHM Mei 2026

No	Jenis	Jumlah Lepas		
		Maret 2026	April 2026	Mei 2026
1	IUD	2	13	15
2	MOW	0	0	0
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0

Grafik 3.5.2

Pelayanan Pelepasan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis:

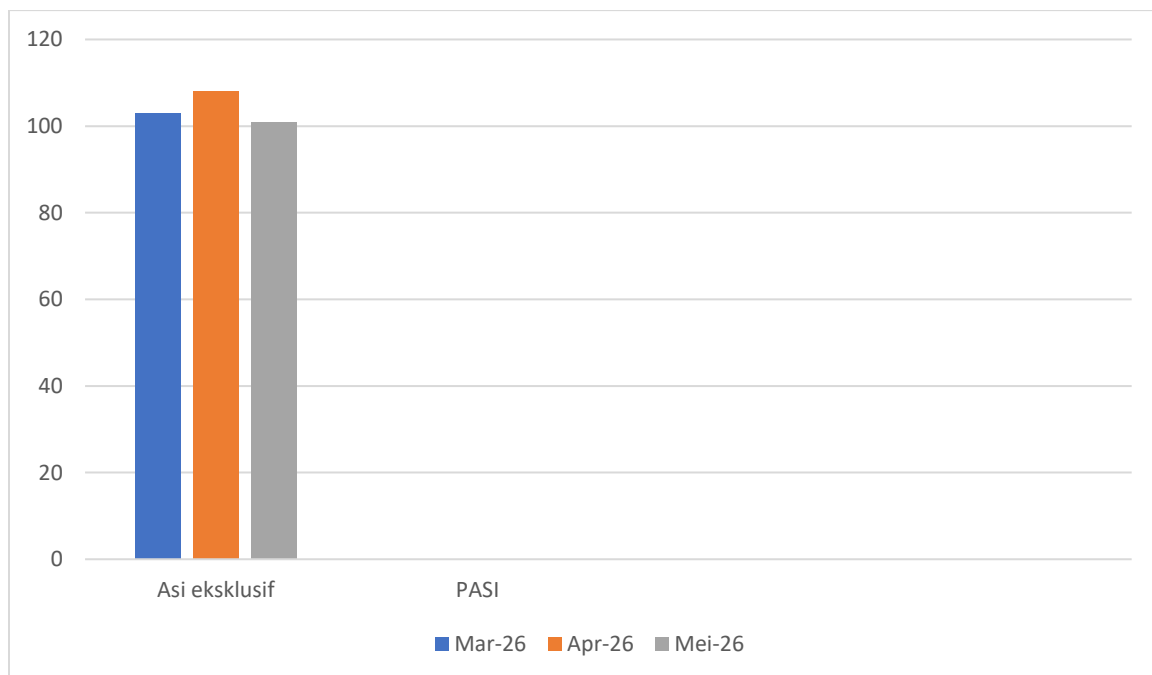
1. Pelepasan KB IUD pada bulan Mei 2026 meningkat yaitu 15 Akseptor, sedangkan pada bulan April 2026 yaitu 13 Akseptor, dan bulan Maret 2026 yaitu 2 Akseptor,
2. Pelepasan KB Implan pada bulan April 2026 dan 2 bulan sebelumnya tidak ada

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3.10. Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif**Tabel 3.3.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Ponpek RSPHM April 2026**

No	Pemberian Asi	Jumlah Pasien					
		Bulan Maret 2026	%	Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%
1	Asi eksklusif	103	100%	108	100%	101	100%
2	PASI	0	0%	0	0%	0	0%
3	Puasa	1		2		1	
Σ kelahiran		104	-	110	-	102	-

Grafik 3.3.10**Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Mei 2026**

Analisis :

- 1) Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Mei yaitu 101 (100%) bayi, pada bulan April 2026 yaitu 108 (100%) bayi, sedangkan Maret sebanyak 103 (100%) bayi. Pemberian ASI sudah memenuhi target yaitu 100% Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2) Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan April dan 2 bulan sebelumnya. Bayi yang menggunakan susu formula pada bayi dengan kondisi tertentu, dan atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Edukasi ASI eksklusif sejak antenatal care
- 2) Melakukan konseling laktasi oleh dokter, bidan dan perawat pada ibu pasca lahiran

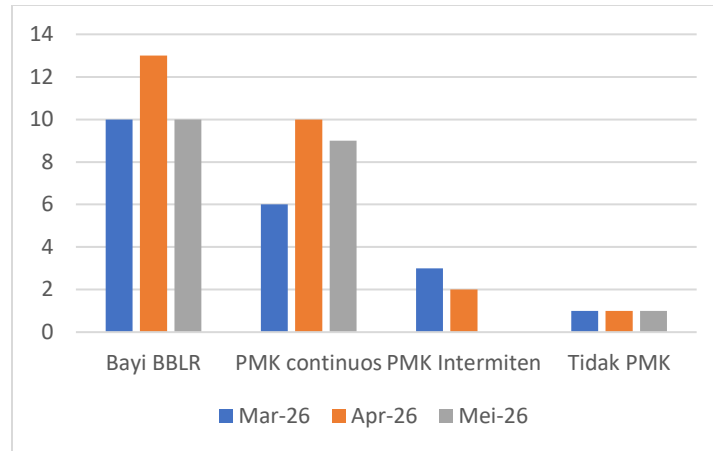
3.3.11. Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel 3.3.11 Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponok RSPHM Bulan Mei 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Maret 2026	Bulan April 2026	Bulan Mei 2026
1	Bayi BBLR	10	13	10
2	PMK continuos	6	10	9
3	PMK Intermiten	3	2	0
4	Tidak PMK	1	1	1

Grafik 3.3.11

Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR Di RS Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis :

- 1) Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500 gram.
- 2) Tidak ada pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Mei 2026, sedangkan pada bulan April 2026 ada 2 bayi, dan bulan Maret ada 3 bayi.
- 3) Sedangkan metode PMK continus pada bulan April 2026 sebanyak 9 bayi, sedangkan pada bulan April 2026 sebanyak 10 bayi, dan Maret sebanyak 6 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil.
- 4) Ada 1 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Mei dan 2 bulan sebelumnya, Hal ini dikarenakan bayi dengan diagnosa NCB, BBLR dan RDS dan bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku
- 2) Memberikan edukasi kepada orang tua bayi untuk melakukan PMK

3.3.12. Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada BBL di Rs Prima Husada Malang

Tabel 3.3.12 Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada BBL di Rs Prima Husada Malang Bulan Mei 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien					
		Bulan Maret 2026	%	Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%
1	Bayi SHK	108	99%	112	99,1%	101	99,1%
2	Bayi Tidak SHK	1	0,9%	1	0,89%	1	0,98%
Σ Kelahiran		109	-	113	-	102	-

Analisis :

1. Pada bulan Mei bayi dilakukan SHK 101 (99,1%) bayi, bayi tidak dilakukan SHK 1 (0,98%) bayi, di karenakan bayi dirujuk kurang dari 24 jam

-
2. Pada bulan April bayi dilakukan SHK 112 (99,1%) bayi, bayi tidak dilakukan SHK 1 (0,89%) bayi, di karenakan bayi dirujuk kurang dari 24 jam
 3. Pada bulan Maret bayi dilakukan SHK 108 (99%), bayi tidak dilakukan SHK 1 (0,9%) dikarenakan bayi meninggal dengan diagnose anechepaly+BBLSR

Rencana dan Tindak Lanjut

1. Mempertahankan cakupan SHK $\geq 99\%$ pada seluruh bayi baru lahir
2. Koordinasi dengan rumah sakit penerima rujukan agar bayi yang dirujuk sebelum 24 jam tetap mendapatkan SHK sesuai jadwal.
3. Memberikan KIE kepada orang tua tentang manfaat SHK untuk deteksi dini hipotiroid kongenital dan dampak keterlambatan diagnosis.

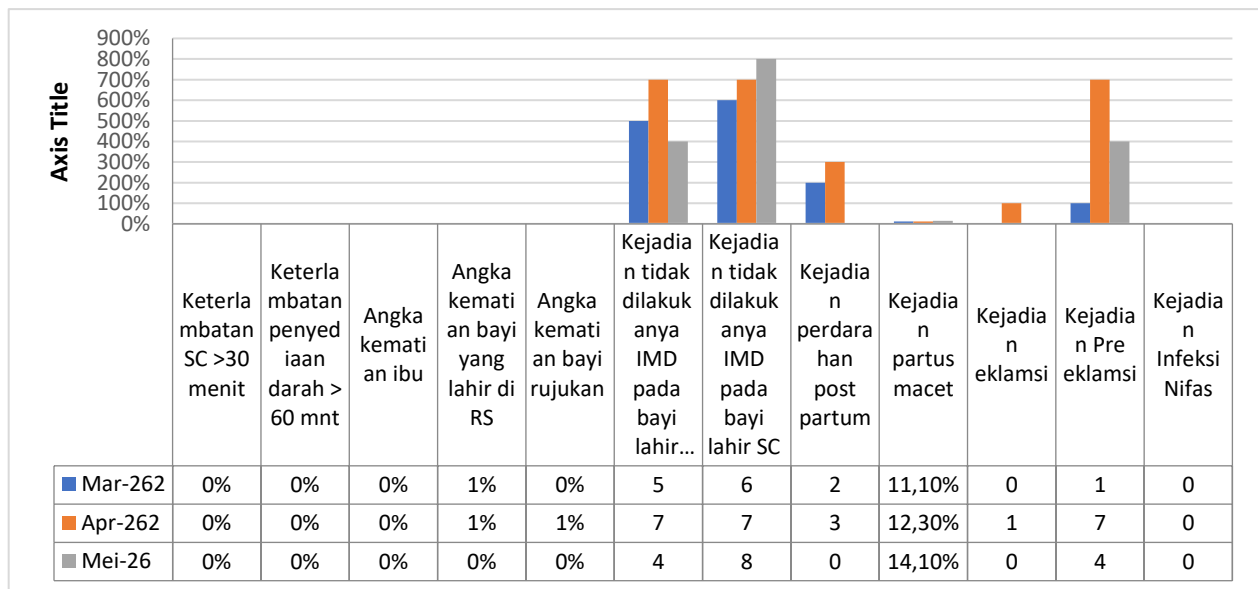
3.4 MUTU

Tabel 3.4 MUTU Ponek RSPHM Mutu bulan Mei 2026

No	Pengukuran Mutu	Standart	Bulan Maret 2026	Bulan April 2026	Bulan Mei 2026
1	Angka keterlambatan operasi section caesaria (SC) >30 menit	0%	0%	0%	0%
2	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%
3	Angka kematian bayi yang lahir di RS	0%	0,96%	0,9 %	0%
4	Angka kematian bayi rujukan	0%	0%	0,9 %	0%
5	Kejadian tidak dilakukanya IMD pada bayi lahir	0%	11	14	12
6	Kejadian perdarahan post partum	0	2	3	0
7	Kejadian partus macet	<10%	11,1%	12,3 %	14,1%
8	Kejadian eklamsi	0	0	1	0
9	Kejadian Pre eklamsi	0	1	7	4
10	Kejadian Infeksi Nifas	0	0	0	0

Grafik 3.4

Mutu PONEK Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis :

- 1) Pada Mutu Angka kematian Ibu pada bulan Mei 2026 dan 2 bulan sebelumnya sebanyak 0%. Hal ini dikarenakan tidak ada kasus kematian Ibu.
- 2) Pada Mutu Angka kematian Bayi lahir di RS pada bulan Mei 2026 sebanyak 0% sedangkan bulan April dan Maret 2026 sebanyak 0,9 %. Hal ini dikarenakan tidak ada kasus kematian bayi pada bulan Mei 2026.
- 3) Pada Mutu Angka kematian Bayi rujukan sebanyak 0% pada bulan Mei 2026. Hal ini dikarenakan tidak ada kasus kematian bayi pada bulan Mei 2026.
- 4) Pada mutu tidak dilakukannya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir persalinan normal Pada bulan Mei 2026 sebanyak 4 bayi, sedangkan tidak dilakukannya IMD pada SC sebanyak 8 bayi.
- 5) Berikut alasan kenapa bayi tidak dilakukannya IMD pada bulan Mei 2026

No	Nama Bayi	Diagnosa	Perawatan BBL
Persalinan Normal			
1	By Ny Firnanda	NKB + BBLR	Cuvis
2	By Ny miftakhul	NCB + BBLR	Infarn Warmer
3	By Ny Yulis	NKB + BBLR	Infarn Warmer
4	Ny Ny Fitri Nadhila	Pneumonia	CPEP + inkubator
SC			
1	By Ny Nuhda Akmalia	NKB + BBLR	Cuvis
2	By Ny Miratus Suaibah	NKB + BBLR	CPEP + inkubator
3	By Ny Elma kania	NCB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Ziadatul Azizah	NKB + BBLR	Cuvis
5	By Ny Siti Kholifah	NKB + BBLR	Cuvis
6	By Ny Mei Ria	NCB + BBLR	Cuvis
7	By Ny Alfiah	NKB + BBLR	Cuvis
8	By Ny Hindun	Obs distres nafas ok Neonatal Pneumonia dd MAS, susp congenital anomaly dd achondroplasia	CPEP + inkubator

Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir dikarenakan bayi lahir dengan BBLR kurang bulan dan Asfiksia, sehingga bayi memerlukan tindakan segera untuk pemasangan alat bantu CPAP dan perawatan incubator. Oleh karena itu bayi tidak dilakukannya IMD. Perawat bayi melakukan IMD sesuai dengan syarat yang telah ditentukan kecuali pada bayi dengan kondisi asfiksia sedang-berat dan kelainan konginetal, pada TM III terjadi peningkatan pada kasus ini, bayi tidak di IMD yang disebabkan karena BBLR dan asfiksia sedang-berat yang membutuhkan perawatan incubator, C-pap dan oksigen.

- 6) Pada kasus pasien pre eklamsi pada bulan Mei sebanyak 4 kasus, sedangkan pada bulan April sebanyak 7 kasus, dan Maret 2026 sebanyak 1 kasus. Untuk kasus Eklamsi pada bulan April sebanyak 1 kasus, sedangkan 2 bulan sebelumnya tidak ada. Unit terkait akan berkolaborasi dengan SP.OG dalam melakukan skrining ibu hamil yang beresiko untuk terjadi eklamsi serta mengedukasi ibu hamil untuk mengonsumsi makanan yang tidak menimbulkan hipertensi.
- 7) Pada kasus Kejadian partus macet pada bulan Mei 2026 meningkat, yaitu sebanyak 14,1 %, sedangkan bulan April 2026 sebanyak 12,3 %, dan bulan Maret sebanyak 11,1 % Kejadian partus macet pada bulan April dikarenakan prolong fase laten, prolong fase aktif, dan kala 2 lama, sehingga pasien dilakukannya operasi SC.
- 8) Tidak ada kejadian perdarahan post partum pada bulan Mei 2026, sedangkan pada bulan April sebanyak 3 kasus, dan Maret sebanyak 2 kasus.
- 9) Tidak ada kejadian Infeksi nifas pada bulan Mei dan 2 bulan sebelumnya.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atau tidak.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makanan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) berkolaborasi dengan SP.OG dalam melakukan skrining ibu hamil yang beresiko untuk terjadi eklamsi serta mengedukasi ibu hamil untuk mengonsumsi makanan yang tidak menimbulkan hipertensi
- 4) Memberikan Edukasi pada Ibu post Nifas terkait gizi yang dibutuhkan ibu Nifas, agar tidak terjadi lagi kasus infeksi pada Ibu nifas.
- 5) Mengevaluasi tiap bulan peningkatan jumlah Kunci indikator mutu PONEK.
- 6) Koordinasi dengan Tim PMKP untuk melakukan pelaporan dan evaluasi setiap bulan, yang nantinya akan dilaporkan ke direktur Rumah Sakit.

3.5 Kelas Senam hamil

Tabel 3.5 Kelas senam hamil RSPHM April 2026

Pengembang an Pelayanan	Hasil kinerja	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
Senam Hamil	- Minggu ke 2 : Anggota : 30 peserta Hadir : 15 peserta. - Minggu ke 4 : Anggota : 30 peserta Hadir : 19 peserta .Target : 1 bulan 2 kali.	Rata-rata kehadiran bulan senam hamil 56,7% Total persalinan 46,7% dari senam hamil yang diselenggarakan di PHM, dengan senam hamil ini dapat menambah citra RS yang lebih baik, menambah kunjungan dan semakin banyak orang yg menyukai RS Prima Husada Malang.	- Berkolaborasi dengan asisten Poli Obgyn untuk mengedukasi pasien hamil uk diatas 22 minggu untuk mengikuti senam hamil. - KIE bahwa kelas senam teradapat Hypnopregnancy yang akan kontinyus dg hypno melahirkan.

	Hasil : 2x/bulan = 34 bumil	Jumlah peserta senam hamil masih belum mencapai target dengan jumlah peserta setiap datang target 30 peserta.	Video Promosi senam hamil yang di tampilkan di IG RS dan di prima menyapa
--	-----------------------------	---	---

Analisis :

1. Peserta senam hamil pada bulan Mei 2026 yaitu 39 pasien, sedangkan pada bulan April 2026 yaitu 44 pasien, dan Maret 0 peserta. Pada bulan maret tidak ada senam hamil karena bulan Ramadhan.
2. Peserta senam hamil pada bulan Mei 2026 yang melahirkan di RS Prima Husada yaitu 46,7% pasien, sedangkan yang lain pasien melahirkan di faskes lain.
3. Dari peserta senam hamil yang melahirkan, pasien mengatakan pada proses persalinan senam hamil dan hypnoterapi sangat membantu.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan penjarangan ibu hamil usia kehamilan 22-24 minggu untuk melakukan senam hamil.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil di ruang tunggu poli untuk melakukan senam hamil
- 3) Berkolaborasi dengan PKRS membuat flayer promosi senam hamil yang ditempatkan di ruang tunggu poli obgyn
- 4) Membuat video promosi senam hamil yang di putar di prima menyapa dan di upload di IG RS
- 5) Mengevaluasi tiap bulan peningkatan jumlah peserta senam hamil.
- 6) Koordinasi dengan Tim PKRS untuk melakukan pelaporan dan evaluasi setiap bulan, yang nantinya akan dilaporkan ke direktur Rumah Sakit.

3.6 PKRS

Tabel 3.6 PKRS Ponek RSPHM Bulan Mei2026

Kegiatan	Target	Maret 2026	April 2026	Mei 2026
Edukasi kelompok	4x/bl	1. Persiapan persalinan 2. Perawatan bayi baru lahir 3. Persiapan senam hamil 4. Manfaat senam hamil	1. Persiapan persalinan 2. Perawatan bayi baru lahir 3. Persiapan senam hamil 4. Manfaat senam hamil	1. Persiapan persalinan 2. Persiapan persalinan 3. Persiapan senam hamil 4. Persiapan persaliann

Edukasi individu	100%	1. Asi Eksklusif 2. Perawatan Payudara 3. Pijat laktasi 4. IMD 5. Personal Hygiene 6. KB 7. Edukasi nyeri post SC		1. Asi Eksklusif 2. Perawatan Payudara 3. Pijat laktasi 4. IMD 5. Personal Hygiene 6. KB 7. Edukasi nyeri post SC		1. Asi Eksklusif 2. Perawatan Payudara 3. Pijat laktasi 4. IMD 5. Personal Hygiene 6. KB 7. Edukasi nyeri post SC	
Kegiatan	Target						
Pembinaan Jejaring	3x/tahun						

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Monitoring

Tabel 4. 1. Hasil Monitoring Ponek RSPHM Mei tahun 2026

No	Bulan	Kegiatan	Jumlah yang dipantau/ diobservasi	Hasil Temuan	Akar Masalah	RTL	PIC	Ket
1	Mei	Kejadian tidak dilakukanya IMD pada bayi lahir	12 bayi	Bulan Mei terdapat 12 bayi yang tidak dilakukan IMD pada persalinan normal dan SC	Bayi dengan kondisi BBLR, Neonatal kurang bulan	1) Skin-to-Skin Contact setelah stabil, dilakukan di ruang NICU/Perinatologi jika memungkinkan. 2) Early Initiation of Expressed Breast Milk (EBM), Ibu dipandu memerah ASI dalam 1–2 jam pertama dan ASI diberikan melalui metode sesuai kondisi bayi 3) Metode Kangaroo Mother Care untuk bayi BBLR stabil.	Tim Ponek	
2		Kejadian perdarahan post partum	0 pasien	Tidak ada kasus perdarahan setelah melahirkan	-	1. Edukasi nutrisi pada saat kehamilan 2. Edukasi pasien untuk rutin melakukan ANC 3. Edukasi ibu hamil untuk melakukan senam hamil	Tim Ponek	

3		Kejadian partus macet	14 pasien	Terdapat kejadian partus macet 14,1%	His dan power pasien tidak adekuat	1. Edukasi pasien saat kemilan untuk melakukan senam hamil dan hypnoterapi 2. Edukasi pasien saat hamil untuk mencukupi kebutuhan nutrisi selama hamil	Tim Ponek	
4		Kejadian Pre eklamsi	4 pasien	Terdapat kejadian pre eklamsi 4 pasien	Tekanan darah tinggi disetujui hasil pemeriksaan protein urin +	1. Edukasi pasien kepatuhan kontrol kehamilan 2. Edukasi pasien untuk pola makan sehat dan istirahat yang cukup 3. Edukasi pasien untuk keputuhan minum obat	Tim Ponek	
5		Kejadian Eklamsi	0 pasien	Tidak terdapat kejadian Eklamsi	-	1. Edukasi pasien kepatuhan kontrol kehamilan 2. Edukasi pasien untuk pola makan sehat dan istirahat yang cukup 3. Edukasi pasien untuk keputuhan minum obat	Tim Ponek	
6		Progam RSSIB	99 pasien	100% pasien ibu dan bayi sudah di lakukan edukasi ibu dan bayi	-	-	Tim Ponek	

4.2.Evaluasi

Tabel 4.2. 1 Hasil evaluasi Ponек Mei 2026

Bulan	Masalah yg dibahas	Hasil Temuan	Akar Masalah	RTL	PIC	Ket
Mei	Pelayanan Imunisasi	Bayi baru lahir tidak mendapatkan imunisasi HB0	1.Vaksin Hb0 di puskesmas terbatas, bulan Mei 2026 bayi baru lahir yang mendapatkan vaksin HB0 dari pemerintah yaitu 29 pasien / 28,4%, bayi yang mendapatkan imunisasi Engerix Junior yaiu (vaksin Hb0 swasta) yaitu 14 bayi, sedangkan jumlah kelahiran bulan Mei yaitu sebanyak 102 bayi. 2.Pasien yang melahirkan di RS Prima Husada tidak hanya dari wilayah singosari melainkan dari luar wilayah Puskesmas singosari	1. Koordinasi dengan Puskesmas Singosari untuk pelaporan vaksin 2. Pengadaan vaksin Engerix Junior	Neonatologi	
	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	IUD pasca lahir	1.Pemasangan IUD pasca lahir 11,1% dikarenakan pemasangan IUD berbayar jika dipasang dokter, dan pasien menginginkan KB selain IUD 2. Pasien memilih KB setelah nifas	1. Melakukan edukasi pasien inpartu, rencana SC,pasien abortus 2. Edukasi pasien dan penunggu di ruang tunggu poli kandungan oleh PJ KBRS	Maternitas	

				3. Membuat flayer KB yang ditempatkan di ruang tunggu poli obgyn		
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4.2.2 Hasil Rekapitulasi Supervisi Bulan Mei 2026

No.	Komponen yang dinilai	Standar	Dilakukan		Temuan	Tindak Lanjut
			Ya	Tidak		
1	Rumah Sakit menetapkan regulasi tentang pelaksanaan PONEK 24 jam.	PONEK 1 EP 1	√	-	Sudah dilakukan revisi 100%	Melakukan monitoring dan evaluasi
2	Terdapat Tim PONEK yang ditetapkan oleh rumah sakit dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya.	PONEK 1 EP 2	√	-	SK Tim Ponek sudah dilakukan revisi 100%	Melakukan monitoring dan evaluasi
3	Terdapat program kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program PONEK Rumah Sakit maksud dan tujuan.	PONEK 1 EP 3	√	-	Sudah dilakukan revisi 100%	Melakukan monitoring dan evaluasi
4	Terdapat bukti pelaksanaan program PONEK Rumah Sakit	PONEK 1 EP 4	√		Bukti laporan tentang pelaksanaan program PONEK pada Laporan Triwulan PONEK dan sudah di Disposisi Direktur	Melakukan monitoring dan evaluasi
5	Program Ponek Rumah Sakit dipantau dan di evaluasi secara rutin	PONEK 1 EP 5	√		Bukti tentang program PONEK Rumah Sakit dipantau dan dievaluasi secara rutin pada Laporan Triwulan PONEK. pelaksanaan pemberian materi edukasi ke pasien : 1. Imunisasi : Hasil supervisi pelaksanaan Imunisasi HB0 42 % dari 60 pasien bayi baru lahir.. 2. KB : Hasil supervisi pelaksanaan KB pasca persalinan 31% dari pasien melahirkan, sedangkan pelaksanaan KB pasca keguguran 100% 3. IMD : hasil supervisi pelaksanaan IMD 100% dari 60 pasien yang di observasi, metode yang digunakan wawancara ke pasien dengan bayi sehat.	Melakukan monitoring dan evaluasi

					4. Asi Eksklusif; hasil supervisi 100 % dari 60 pasien yang di observasi, metode yang digunakan wawancara ke pasien 5. PMK : hasil supervisi 100% dari 19 pasien yang di observasi, metode yang digunakan wawancara ke pasien 6. Perawatan BBL : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan BBL 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 7. Makan & minum ibu menyusui : hasil supervisi pelaksanaan edukasi makan minum ibu menyusui 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 8. Cek ASI : hasil supervisi pelaksanaan cek ASI 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 9. Rawat gabung: hasil supervisi pelaksanaan rawat gabung 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 10. Menyusui Bayi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi menyusi bayi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 11. Perawatan Payudara : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan payudara 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 12. Personal Hygine : hasil supervisi pelaksanaan edukasi personal Hygine 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 13. Perawatan luka post sc+post partum : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan luka post op sc dan post partum 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 14. Pijat laktasi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi pijat laktasi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien	
--	--	--	--	--	--	--

					Materi edukasi Tersedia elektronik dan fisik dilengkapi dengan barcode 15. Menjemur bayi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi menjemur bayi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 16. Perawatan tali pusat : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan payudara 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 17. Memandikan bayi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi memandikan bayi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien. Berikut media edukasi promosi kesehatan https://sites.google.com/view/rsprimahusada/leaflet	
6	Rumah sakit menetapkan program pembinaan jejaring rujukan rumah sakit.	Ponek 1.1 EP 1	√			
7	Rumah sakit melakukan pembinaan terhadap jejaring secara berkala.	Ponek 1.1 EP 2	√		Pembinaan jejaring dilakukan pada bulan januari 2026	Melakukan monitoring dan evaluasi
8	Telah dilakukan evaluasi program pembinaan jejaring rujukan	Ponek 1.1 EP 3	√		Rujukan masuk bulan Mei yaitu 10 pasien saat merujuk sudah dilakukan penatalaksanaan awal rujukan, perujuk sudah konfirmasi ke RS	monitoring dan evaluasi

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan Ponek bulan Mei 2026 disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang . Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.

Ketua Tim PONEK


dr. Aida Musyarofah, Sp. OG

Malang, 3 Juni 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes